游离甲状腺素校准品说明书

【产品名称】

通用名称：游离甲状腺素校准品

英文名称：Access® Free T4 Calibrators

【包装规格】

校准品 0(S0)–校准品 5(S5)，2.5 mL/瓶

【预期用途】

本产品用于游离甲状腺素测定项目的校准。

Access 游离甲状腺素校准品用于校准Access 游离甲状腺素测定，以通过使用Access免疫测定系统定量测定人血清与血浆 (肝素) 的游离甲状腺素水平。

【检验原理】

定量测定的校准是一个如同测试病人样本那样，对已知分析物浓度的样本 (如，测定的校准品) 进行测试以计算其反应值的过程。测得的反应值与已知分析物浓度之间的数学关系，可用于确立校准曲线。此数学关系，或校准曲线，用于将病人样本的RLU (光量子值) 测定值转换为特定的定量分析物浓度。

【主要组成成分】

校准品0(S0):	含< 0.1% 叠氮钠和0.5% ProClin 300 的人血清。含0.0 ng/dL (0.0 pmol/L) 甲状腺素。
校准品1(S1), 校准品2(S2), 校准品3(S3), 校准品4(S4), 校准品5(S5):	在人血清(含< 0.1% 叠氮钠和0.5% ProClin 300) 中，水平分别大约为 0.5 、1.0、2.0 、3.0 和6.0 ng/dL (大约为6.4 、12.9 、25.7 、38.6 和 77.2 pmol/L) 的游离甲状腺素。
校准卡:	1

溯源性

Access 游离甲状腺素校准品内的分析物，可溯源至生产商的工作用校准品。 溯源性的建立过程是按EN ISO 17511 进行的。

使用这一批次校准品中具有代表性的样本建立指定的值，该值对于Access 试剂的测定方法是特定的。使用其它方法确定的值可能会存在差异。若此差异存在，可能是不同方法之间的偏倚造成的。

【储存条件及有效期】

•在≤-20℃储存，有效期为12个月。

• 即用型。

• 在-20℃及更低温环境下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期。

• 在-20℃及更低温环境下保存时，可稳定保存12个月。

• 使用前需在室温下解冻，缓慢混匀后方可使用。应避免形成气泡。

• 解冻后校准品需在室温下稳定2 小时。

• 每次使用后，应将校准品放回至-20℃保存。

• 校准品不应反复解冻超过5次。

• 可能存在变质情况的表现为质控值超出了范围。

• 参考校准卡以获得准确的浓度值。

• 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access 2、Unicel Dxi 600 Access和Unicel Dxi 800 Access 免疫分析系统

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入和评论校准数据的信息。

2.使用前轻轻倒转，混匀成份。防止形成气泡。

3. Access 游离甲状腺素校准品提供时为零以及大约0.5、1.0、2.0、3.0 和6.0 ng/dL。校准品是由纯化的甲状腺素和人血清制备的。测定校准数据的有效期长达28 天。

校准品的测定应做双份。

【检验方法的局限性】

与Access免疫测定系统及配套试剂使用。

试剂内如有微生物污染的迹象或显著浑浊，应弃去。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 经过测试发现用于制备试剂的人源性材料，对于乙型肝炎、丙型肝炎(HCV) 和人体免疫缺陷病毒(HIV-1 和HIV-2) 抗体，均显示为无反应。由于任何已知的测试方法均无法完全确保不存在感染性物质，因此处理试剂与病人样本时均视其具有传染疾病的可能。[19]
- 经过测试发现用于制备该产品的每种血清/ 血浆池，均对纤维蛋白原表现为阴性。
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[4]
- Xi. 刺激物： 0.5% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤，可引起致敏作用。

S 28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套

- 材料安全数据资料 (MSDS) 可按需索取。

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【参考文献】

1 1 Gornall, AG, Luxton, AW, Bhavnani, BR. Endocrine Disorders. In Applied biochemistry of clinical disorders. 1986;305-318. Philadelphia, PA: J. B. Lippincott Co.
2 White, GH. Recent advances in routine thyroid function testing. CRC - Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences. 1987; 24: 315-362.
3 3Watts, NB, Keffer, JH. The thyroid gland. In Practical Endocrine Diagnosis. 1982; 77-96. Philadelphia, PA: Lea & Febiger.
4 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
5 Approved Guideline – Procedures for the handling and processing of blood specimens, H18-A2. 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
6 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
7 Kricka, L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037.
8 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
9 Liewendahl, K, Majuri, H, Helenius, T. Thyroid function tests in patients on long-term treatment with various anticonvulsant drugs. Clinical Endocrinology, 1978; 8: 187-191.
10 Wenzel, KW. Pharmacological interference with in vitro tests of thyroid function. Metabolis. 1981; 30 (7): 717-732.
11 Wilke, TJ. Estimation of free thyroid hormone concentrations in the clinical laboratory. Clinical Chemistry. 1986;32 (4): 585-592.
12 Spencer, CA. Thyroid status: trends in testing – selective test use cuts cost. Clinical Chemistry News. November,1989; 15 (11): 9-14.
13 Demers LM, Spencer CA. Laboratory medicine practice guidelines – Laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. The National Academy of Clinical Biochemistry. Available http://www.nacb.org/lmpg/thyroid_lmpg_pub.sm.
14 Lee, SL. When is the TSH normal? New criteria for diagnosis and management. 12th Annual Meeting of the Americal Association of Clinical Endocrinologists (AACE), May, 2003.
15 Haugen, BR. When isn't TSH normal and why? Clinical implications and causes. 12th Annual Meeting of the Americal Association of Clinical Endocrinologists (AACE), May, 2003.
16 Singer, PA. Now it's normal – now it's not: food for thought from a complex case. 12th Annual Meeting of the Americal Association of Clinical Endocrinologists (AACE), May, 2003.
17 Tentative Guideline - Internal quality control: Principles and definitions, C24-T. 1987. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
18 Krouwer, JS, Rabinowitz, R. How to improve estimates of imprecision. Clinical Chemistry. 1984; 30: 290-292.
19 HHS Publication, 4th ed., May 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, MN 55318-1084, USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 400885535

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 400885535

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20162401145

【说明书核准日期及修改日期】

2020-07-31

2020-11-28

2022-06-30